10 Pouca comida para muito treino: deficiência energética relativa no esporte

O problema oposto ao do suplemento. Na adolescência, a energia que falta disputa espaço com o crescimento, a puberdade e o osso.

DEFINIÇÃO DO COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL, 2023

O que é REDs (Relative Energy Deficiency in Sport)

Síndrome de prejuízo do funcionamento fisiológico e psicológico, em atletas de ambos os sexos, causada pela exposição prolongada ou intensa à baixa disponibilidade de energia. As consequências incluem queda do metabolismo energético, da função reprodutiva, da saúde musculoesquelética, da imunidade, da síntese de glicogênio e da saúde cardiovascular e hematológica, com prejuízo do bem-estar, mais risco de lesão e pior desempenho[1].

Tradução livre do quadro de definições do consenso.

POR QUE PESA MAIS NO ADOLESCENTE

- No atleta em desenvolvimento, a baixa disponibilidade de energia pode atrasar a puberdade, alterar os ciclos menstruais, prejudicar o osso, reduzir a estatura final, favorecer transtornos alimentares e aumentar o risco de lesão[2].
- Até 36% do conteúdo mineral ósseo total do adulto é adquirido nos 4 anos em torno do pico de velocidade de crescimento[3].

Baixa disponibilidade de energia é qualquer descompasso entre a energia ingerida e a gasta no exercício que deixa sem cobertura as necessidades totais do corpo[1]. Quando falta energia, o organismo a desvia de outros processos, em especial do crescimento, da reprodução e da manutenção[1].

QUEM ESTÁ EM RISCO

Ambiente e temperamento

- Esportes que valorizam a magreza, em que insatisfação corporal e alimentação perturbada são conhecidas há anos[2].
- Comentários descuidados de treinadores sobre peso ou aparência, que podem precipitar ou perpetuar transtornos alimentares[2].
- Perfeccionismo, alta tolerância à dor e motivação elevada, qualidades valorizadas no esporte competitivo[2].
- Mais de um esporte ao mesmo tempo, trabalho e mudanças de carga, que alteram a necessidade de energia[2].

O QUE APARECE NA CONSULTA

Sintomas e sinais

O adolescente conta: dor de lesão óssea por estresse, amenorreia, tristeza, fome, queda da libido, estagnação ou queda de desempenho[1].

O pediatra encontra: mudança importante de hormônios sexuais, da taxa metabólica de repouso ou do colesterol em relação ao basal do atleta[1]; densidade mineral óssea baixa e queda nas curvas de crescimento pediátricas[3].

FERRAMENTA DO CONSENSO

Como a ferramenta de avaliação clínica do Comitê Olímpico Internacional organiza a avaliação

Nome original: IOC REDs Clinical Assessment Tool, versão 2 (CAT2), em que IOC é a sigla inglesa do Comitê Olímpico Internacional[3].

1. Rastreio

Questionário validado para a população ou entrevista clínica[1]. Um exemplo é o LEAF-Q (Low Energy Availability in Females Questionnaire), com 25 itens, sensibilidade de 78% e especificidade de 90%; foi testado em 84 atletas de 18 a 39 anos, com validade avaliada em 45 atletas de resistência, e não em adolescentes[4].

2. Gravidade e risco

Estratificação em quatro níveis, com orientação para treinos e competições[3].



3. Diagnóstico médico

Feito por médico com experiência no tema, com plano de tratamento construído com o atleta, o treinador e a equipe[3].

Não existe método diagnóstico único validado[1]. Há bem menos dados sobre o uso da ferramenta antes ou durante a puberdade, e os pais ou responsáveis participam do plano quando o atleta tem menos de 18 anos[3].

NA PRÁTICA DO PEDIATRA

- Pergunte por menarca, ciclos, lesões ósseas por estresse, fome, cansaço e humor; registre peso e estatura nas curvas a cada consulta.
- No adolescente em crescimento, prefira manter o peso a perder peso; restrição intensa e prolongada não é recomendada[2].
- Avaliação de composição corporal em menores de 18 anos só com finalidade médica[1].
- Nenhum suplemento repõe a energia que falta: o plano começa pela comida e pela carga de treino.

PREVENÇÃO QUE CABE NA ROTINA

- Educação e menos ênfase no peso e na magreza estão entre as estratégias mais importantes, sobretudo em atletas jovens e não profissionais[5].
- A base do tratamento é identificar a origem da baixa disponibilidade de energia e tratá-la[5].
- Combine com o treinador que o peso não será discutido no vestiário (modelo de carta no item 18).

LIGAÇÃO COM A AULA

O adolescente que pede whey para “ganhar massa” e o que pula refeições para “secar” podem ter a mesma raiz: um ideal de corpo que passa a comandar a comida. Nos dois casos, a conversa começa por quanta energia ele come e quanto gasta.

FONTES

1. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, Burke LM, Constantini N, Hackney AC, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-97. doi:10.1136/bjsports-2023-106994
2. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
3. Stellingwerff T, Mountjoy M, McCluskey WT, Ackerman KE, Verhagen E, Heikura IA. Review of the scientific rationale, development and validation of the International Olympic Committee Relative Energy Deficiency in Sport Clinical Assessment Tool: V.2 (IOC REDs CAT2)-by a subgroup of the IOC consensus on REDs. Br J Sports Med. 2023;57(17):1109-18. doi:10.1136/bjsports-2023-106914
4. Melin A, Tornberg AB, Skouby S, Faber J, Ritz C, Sjödin A, et al. The LEAF questionnaire: a screening tool for the identification of female athletes at risk for the female athlete triad. Br J Sports Med. 2014;48(7):540-5. doi:10.1136/bjsports-2013-093240
5. Torstveit MK, Ackerman KE, Constantini N, Holtzman B, Koehler K, Mountjoy ML, et al. Primary, secondary and tertiary prevention of Relative Energy Deficiency in Sport (REDs): a narrative review by a subgroup of the IOC consensus on REDs. Br J Sports Med. 2023;57(17):1119-26. doi:10.1136/bjsports-2023-106932